

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	急性胰臟炎 Acute pancreatitis				
編號	A31000-Q03-W-D06	制定者	N08 李昀臻	公布日期	104 年 07 月 10 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 11 月 21 日
版本/總頁數	第 1.8 版/9 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

讓護理人員了解急性胰臟炎的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

指因胰臟分泌的酵素造成自體溶解，而導致胰臟有發炎、出血及壞死現象。

1. 急性胰臟炎：是一種急性炎症過程的疾病，會因胰管阻塞造成胰臟所分泌的酵素無法通過，導致器官本身自我溶解，好發於中年男性，男性常因大量喝酒而引發，女性多因膽結石所引發。
2. 慢性胰臟炎：是一種慢性漸進性炎症過程的疾病，大多因急性胰臟炎所引發，最後會導致胰臟纖維化及壞死。好發年齡為 45~60 歲。女性大多因膽道疾病所併發。

（二）症狀

1. 急性胰臟炎：

- (1)腹痛：在發作 24 小時內，上腹部或左上象限疼痛，會放射到背部和上腹部出現劇痛。進食脂肪食物或喝酒及俯臥姿勢會使疼痛加劇。採胎兒姿勢會使疼痛減輕，如脊椎彎曲，將膝盡量屈向胸部，或坐著且向前彎曲的姿勢。

主題名稱	急性胰臟炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D06	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	2/9

(2)體重減輕、噁心、嘔吐；發燒、心搏過快、血壓降低等。

(3)皮膚顏色：出現黃疸、卡倫徵象（Cullen's sign 即腹部和肚臍周圍出現藍色現象）、透納徵象（Turner's sign 即腰窩處出現瘀斑）。

(4)腸蠕動音消失或減弱；腹部脹痛、僵硬。

(5)呼吸困難、端坐呼吸、出現異常呼吸音、肋膜積水、肺水腫。

2. 慢性胰臟炎：

(1)腹部疼痛，為持續性、燒灼性脹痛；左上象限可以摸到腫塊；胰臟性腹水。

(2)呼吸困難、端坐呼吸；脂肪痢、惡臭味脂肪便；黃疸、茶色尿；體重減輕；血糖升高。

（三）常見檢查

1. 實驗室檢查：

(1)胰澱粉酶(Amylase)：升高，大於 200U/dl（正常值：60~160 U/dl）。

(2)解脂酶(Lipase)：升高（正常值：0~1.5 U/dl）。

(3)解脂酶(Lipase)或胰澱粉酶(Amylase)可能上升超過正常值的三倍。

(4)尿素胰澱粉酶：升高，每天排出量大於 360U/dl（正常值：43~245 U/dl）。

(5)血清葡萄糖：升高（正常值：80~120 mg/dl），因胰臟β細胞受損，導致碳水化合物代謝受損。

(6)血清鈣：降低（正常值：8.4~10.6 mg/dl）；脂肪性壞死後，脂肪酸與鈣結合所致。

(7)膽紅素：升高（正常值：0.2~1.6 mg/dl）；因肝膽結石所致。

(8)鹼性磷酸酶(Alkaline phosphate)：升高（正常值：30~90 U/dl）。

(9)白血球(WBC)：增加；因感染反應所致。

2. 放射學檢查：

(1)電腦斷層掃描(Computed Tomography, CT)：作為炎症、腫瘤的確定性診斷。

(2)胸部 X 光：顯示肋膜積水、肺炎等症狀。

主題名稱	急性胰臟炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D06	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	3/9

(3)超音波檢查：可顯示水腫、發炎、鈣化、囊腫或腫瘤等情形。

(4)經內視鏡逆行性膽胰管攝影術(Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography, ERCP)：為膽道結石所引起的胰臟發炎。

3. 急性胰臟炎的預後：

急性胰臟炎的預後常依蘭森(Ranson)準則而定，如下表。

住院時			住院後最初 48 小時		
	酒精性	非酒精性		酒精性	非酒精性
年齡	>55 歲	>70 歲	Hct 下降	>10%	>10%
白血球數	>16,000/mm ³	>18,000/mm ³	BUN 上升	>5 mg/dl	>2 mg/dl
血糖值	>200mg/dl	>220mg/dl	血鈣值	<8mg/dl	<8mg/dl
AST(SGOT)	>250U/L	---	動脈氧分壓	<60mmHg	---
LDH	>350 U/L	>400 U/L	鹼基短缺值	>4mEq/L	>5mEq/L
			體液喪失量	>6L	>4L

(四) 常見治療

- 急性期需禁食，經醫師評估放置鼻胃管以減輕噁心、嘔吐、腹痛腹脹等症狀。
- 止痛劑：給予 Demerol 與 Morphine 等，但有學者並不支持使用 Morphine，因它為 Oddi 括約肌之強力收縮劑，會使胰管內壓力上升，造成胰臟炎或膽囊疼痛加劇，雖然無實證資料可加以證明，故一般不建議使用超過 3 天，避免藥物蓄積作用導致肌肉痙攣或癲癇等不良反應發生。
- 其他藥物：(1)Atropine：減緩胰臟活動，減少胰臟酵素的分泌；(2)抗生素：控制發炎過程；(3)葡萄糖鈣(Calcium Gluconate)：用以矯正低血鈣；(4)碳酸氫鈣(NaHCO₃)：用以矯正代謝性酸中毒；(5)胰島素：矯正高血糖。
- 氧氣吸入：減輕呼吸困難的症狀。
- 飲食：急性胰臟炎在剛開始恢復進食時，因脂肪及蛋白質會刺激胰液分泌，故建議採低蛋白、低脂肪及高碳水化合物飲食，之後可以逐漸增加蛋白質的攝取量；於康復期則採取清淡、高蛋白、低脂肪、高碳水化合物飲食。慢性胰臟炎病人需補充脂溶性維生素及膽鹽。
- 接受胰臟手術病人須終身服用胰臟酵素，包含胰澱粉酶、胰脂肪酶及胰蛋白酶。

主題名稱	急性胰臟炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D06	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	4/9

7. 抗痙攣劑：降低迷走神經刺激、抑制酵素分泌。

(五) 護理問題

1. 發燒／和炎症過程有關。
2. 體液容積不足／與禁食、噁心、嘔吐有關。
3. 疼痛不適／與發炎過程和酵素滲漏有關。
4. 排便異常：腹瀉／與脂肪吸收不良有關。
5. 缺乏營養／與噁心、嘔吐、腹脹有關。

(六) 護理措施

1. 發燒／和炎症過程有關。
 - (1) 監測生命徵象的變化，發燒時協助冰枕使用及減少被蓋，調整室內空調，維持室溫在 20-24℃ 間。
 - (2) 監測實驗室檢驗值，如血液、尿液、細菌培養等。
 - (3) 協助調整衣服被蓋，維持身體清潔舒適與乾爽。
 - (4) 視需要補充水分及依醫囑予靜脈輸液。
 - (5) 依醫囑給抗生素治療。
 - (6) 依醫囑給予解熱鎮痛劑。
2. 體液容積不足／與禁食、噁心、嘔吐有關。
 - (1) 監測生命徵象、意識狀態及有無休克症狀。
 - (2) 每天測量並記錄輸出入量、體重，以評估體液平衡狀態。
 - (3) 觀察體液電解質不平衡之症狀與徵象的變化。
 - (4) 了解供給體液的適應症和禁忌症。
 - (5) 依醫囑必要時監測血液及生化檢查值。
3. 疼痛不適／與發炎過程和酵素滲漏有關。
 - (1) 監測生命徵象、意識狀態及有無休克症狀。
 - (2) 觀察、進行急性疼痛評估（包含評估疼痛部位、特性、時間、頻率、性質、強度或嚴重度）與記錄，並告知醫師。

主題名稱	急性胰臟炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D06	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	5/9

(3)急性疼痛時，鼓勵多休息與採舒適姿勢臥床休息，減少干擾休息因素來促進復原。

(4)觀察病人不舒適的非語言暗示，特別是那些無法有效地溝通之病人。

(5)確認病人有接受適當之止痛照護。

(6)提供病人及家屬尋求及提供心理支持。

(7)選擇疼痛緩解措施時，須考慮疼痛的型態及位置。

(8)依醫囑給予適合之止痛藥，緩解疼痛。

(9)評估病人的疼痛經驗，以評值疼痛控制措施的成效。

(10)評估止痛藥之效果及有無副作用。

(11)轉移其注意力，如聊天、聽音樂。

4. 排便異常：腹瀉／與脂肪吸收不良有關。

(1)觀察排便次數、性狀、量和味道，是否出現惡臭味脂肪便。

(2)急性期或腹瀉嚴重時，經醫師評估需禁食。

(3)限制脂肪攝取量，並改變飲食種類。例如：將全脂奶粉改成脫脂奶粉；油炸及煎的烹煮方式改為水煮及清蒸的方式。

(4)慢性胰臟炎的病人需依醫囑補充膽鹽與脂溶性維生素。

(5)排便後須清潔會陰處，以防造成皮膚破損。

5. 缺乏營養／與噁心、嘔吐、腹脹有關。

(1)每次進餐前或嘔吐後，協助進行口腔護理。

(2)提供少量多餐的進食方式，避免攝取高脂肪的食物，例如：將全脂奶粉改成脫脂奶粉；油炸及煎的烹煮方式改為水煮及清蒸的方式。

(3)觀察進食後的情形，是否會出現腹脹、噁心、嘔吐、灰色便或脂痢現象，若出現則應以少量多餐方式進食，並修改進食內容及烹煮方式。

(4)依醫囑補充維生素與礦物質。

(5)依醫囑給予制酸劑、止吐劑等以減輕不適，增加進食量。

(6)避免給予咖啡、茶、產氣性及刺激性食物。

主題名稱	急性胰臟炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D06	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	6/9

(7)依醫囑給予胰島素時，需特別注意其副作用並評值營養攝取改善情形。

(8)定期監測病人血液中胰澱粉酶(Amylase)、解脂酶(Lipase)的變化。

(七) 衛教指導

1. 發燒時應減少被蓋，調整室內空調，維持室溫在 20-24℃ 間，保持身體清潔舒適與乾爽。
2. 急性疼痛時，鼓勵多休息與採舒適姿勢臥床休息，減少干擾休息因素來促進復原。
3. 轉移其注意力，如聊天、聽音樂。
4. 採少量多餐的進食方式，避免攝取高脂肪的食物，例如：將全脂奶粉改成脫脂奶粉；油炸及煎的烹煮方式改為水煮及清蒸的方式。
5. 觀察進食後的情形，是否會出現腹脹、噁心、嘔吐、灰色便或脂痢現象，若出現則應以少量多餐方式進食，並修改進食內容及烹煮方式。
6. 排便後須清潔會陰處，以防造成皮膚破損。
7. 避免進食咖啡、茶、產氣性及刺激性食物。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 吳佳憲、范郁敏、高士勛、方冠傑、蘇建維(2019)・急性胰臟炎的診斷與治療之新進展・臨床醫學月刊，84(3)，623-632。

主題名稱	急性胰臟炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D06	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	7/9

[https://doi.org/10.6666/ClinMed.201909_84\(3\).0102](https://doi.org/10.6666/ClinMed.201909_84(3).0102)

(二) 徐子婷、蔡惠如、江怡瑩、孫國紹(2021)・照護一位糖尿病病人使用生酮飲食合併急性胰臟炎之護理經驗・志為護理-慈濟護理雜誌，20(4)，78-87。

(三) Sinonquel, P., Laleman, W., & Wilmer, A. (2021). Advances in acute pancreatitis. Current opinion in critical care, 27(2), 193–200.

<https://doi.org/10.1097/MCC.0000000000000806>

(四) Basit, H., Ruan, G. J., & Mukherjee, S. (2022). Ranson Criteria. In StatPearls. StatPearls Publishing.

七、附件

(略)

主題名稱	急性胰臟炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D06	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	8/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
104.07.10	1.0	新制定。	104 年 07 月 10 日護理部照護標準委員會通過；104 年 07 月 10 日公布。
105.08.31	1.1	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 更新第六項參考資料。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	1.2	第三項第(三)目之 3 部份修辭。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
107.06.29	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	1.3	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.09.23	1.4	1. 第三項第四目之 2 說明內容修訂。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 3. 新增第六項第三、四目參考資料。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	1.5	第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.10.19	1.6	1. 第三項第四目之 2 說明內容修訂。 2. 第六項參考資料修訂。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過； 110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	1.7	1. 第三項第五、六目之護理問題修訂。 2. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年

